

23/10
10h

Umid: H36920237F69E
Modem: WD87373161056

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS J3669216956DS

ZILSON GALDINO DA CUNHA

IDADE: 67 PESO: 90 ALTURA: 1,80 PROFISSÃO: Aposentado (gente produção)
SINTOMAS: memória, sonolência diurna
QUEIXAS: Roncos e engasgos presenciados
MEDICAMENTOS: Nebilet / Rosuvastatina / Almsartan / Klev / Enxetmibic / ancoron / auladipino.
MÉDICO: Dr. Luciana Vaz (neuro)
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N
EXERCÍCIO FÍSICO: Academia 5x
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 20h
HORA QUE DORME: 22:30-23h HORA QUE ACORDA: 7h
COCHILHO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 10x
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 634e/h SPO2: 86%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC:
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA
(N) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS

18/09/24 Avaliação

25/09/24 P= 5,8 cmH₂O

IAH= 2,6 e/h

m de uso: 6h42'

Bem adaptado

S/ queixas

Natacha

07/10/24 P= 6,6 cmH₂O

P= 90% → 9,0 cmH₂O

IAH= 6,0 e/h

m de uso: 6h40 min

fuga: 0

queixa de acordar mole nas últimas noites

↑ P: 6 a 10,5 cmH₂O

Silvi

17/10/24 P= 7 cmH₂O / Pao= 10 cmH₂O

IAH= 6 e/h

m de uso: 6h23'

fuga:

Bem adaptado

Deixa sentir-se confortável

Natacha

21/11/24 P= 7,2 cmH₂O / Pao: 9,0 cmH₂O

IAH= 6,9 e/h

m de uso: 5h54'

fuga: 13s

Natacha

27/12/24 P= 7,5 cmH₂O P₉₀: 10,1 cmH₂O

IAH= 9,4 elh

m.uro = 6h15 min

↑ Auto 7a 11 cmH₂O

refere sono agitados
na remo
q/ ↑ IAH

23/01/25 P= 7,6 cmH₂O (media)

IAH= 3,2 elh

m. de uro: 6h18m

Bem adaptado
S/ queixas
natado

20/02
25

P= 10,1 cmH₂O

IAH= 10,2

m. de uro: 5h13'

Peso 92 Kg
Dorme 22hrs acorde
sua

17/03/25

P= 10,5 cmH₂O

IAH= 1,1 elh

m. uro= 6h37min

Bem adaptado

* deu bexa aparelho no chao →
porta filtro pouco aberta, mas
funcionamento normal si.

30/04/25

P= 10,5 cmH₂O

IAH= 1,7 elh

m. uro= 7h10

fuga= 8 seg.

queixa sono agitado / disputa sentindo mlt
no baixa: opko pa ↑ P: 10,0 cmH₂O si

24/07/25

P= 10,0 cmH₂O

IAH= 0,5 elh

m. uro= 6h50min

fuga= 0 seg.

Acordando pra ir banheiro

- Neuro esta tomando clonazepam (clonazepam);
ha 1 mes. Demencia Parkinson / Alzheimer

Nome: ZILSON GALDINO DA CUNHA

Data de Nascimento: 2-6-1957

IMC: 27,78

Sexo: Masculino

Data do exame: 30-08-2024

Peso: 90 kg

Altura: 1,80 m

Médico: DRA. LUCIANA ABIFADEL

LAZZARINI VAZ

Medicamentos:

Histórico:

Lauda de Polissonografia

Exame realizado na noite de 30-08-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletroculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 495,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 10,0 e 131,5 minutos. O tempo total de sono foi de 391,0 min, eficiência de 79,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 62,4%; estágio N3: 11,8%; sono REM: 23,7%. O índice de despertares foi de 34,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 63,4/hora, sendo 105 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 83 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 86%, permanecendo 3,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 50 - 67 bpm e NREM de 47 - 71 bpm.

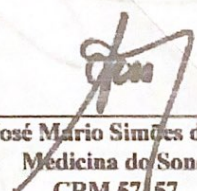
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 63,4/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=86%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157